SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

BÁO CÁO GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN CẢ NĂM 2025

TP. Châu Đốc, tháng 01 năm 2026

GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN NĂM 2025

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế (gọi tắt là nhiễm khuẩn bệnh viện) là các nhiễm khuẩn xảy ra trong quá trình người bệnh được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Nhiều nghiên cứu cho thấy NKBV làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện trung bình từ 7 -15 ngày, tăng việc sử dụng kháng sinh, tăng đề kháng kháng sinh và chi phí điều trị.Theo một nghiên cứu của Hoa Kì chi phí điều trị cho một ca NKBV tăng 2-4 lần so với không NKBV. Do đó ,đây là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới
- Tác nhân gây NKBV đã có nhiều thay đổi trong vài thập kỷ qua. Các vi khuẩn gây bệnh có thể là các vi khuẩn gram dương và các trực khuẩn Gram (-), nấm, và ký sinh trùng. Tuy nhiên, NKBV do trực khuẩn Gram (-) đa kháng thuốc kháng sinh đã và đang trở thành một tai hoạ thực sự cho các bệnh viện.
- Các nhiễm khuẩn thường gặp ở bệnh viện: Viêm phổi bệnh viện là nhiễm khuẩn thường gặp trong NKBV và tỷ lệ mắc từ 15% đến 20% tổng số NKBV. Nhiễm khuẩn vết bỏng, Nhiễm khuẩn vết mổ, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết. Ngoài ra, còn một số nhiễm khuẩn như: nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn dạ dày - ruột, viêm xoang, nhiễm khuẩn mắt và kế mạc, viêm màng nội mạc tử cung, …
- Nghiên cứu về hiệu quả của chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK), bệnh viện SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) năm 1970 – 1976 đã chứng minh rằng 1 chương trình kiểm soát NKBV bao gồm giám sát và áp dụng kỹ thuật có thể làm giảm 33% NKBV.
- Giám sát NKBV từ đó đánh giá được tình hình nhiễm khuẩn và có kế hoạch can thiệp kịp thời, cải tiến các biện pháp kiểm soát NKBV nhằm làm giảm đến mức tối đa tỉ lệ NKBV.

II.MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa Ngoại TQ, Ngoại CT, Nội TQ, Nội Tiêu hóa, Nội nhiễm, Nhi, Sản, HSCC tại BV Nhật Tân.

2. Mục tiêu cụ thể:

Xác định các yếu tố liên quan đến NKBV

III.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. **Phương pháp:** Mô tả cắt dọc
2. **Thời gian thực hiện:** 01/01/2025 đến 31/12/2025
3. **Đối tượng:**

   Tất cả bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các khoa Ngoại TQ, Ngoại CT, Nội TQ, Nội Tiêu hóa, Nội nhiễm, Nhi, Sản, HSCC tại BV Nhật Tân..
4. **Tiêu chuẩn loại trừ:**

   Bệnh nhân đã bị nhiễm khuẩn trước khi nhập viện
5. **Tiêu chuẩn chẩn đoán:**

   Dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn bệnh viện của CDC tháng 1/2013.
6. **Phương pháp thu thập số liệu:**

   Thu thập thông tin trên hồ sơ bệnh án

   Công cụ: phiếu điều tra NKBV.

   Người giám sát: CN.Nguyễn Thị Diễm Phương, DS. Bùi Thị Minh Thư
7. **Phân tích và xử lý số liệu:**

   Số ca nhiễm khuẩn N = 02 ca (Sản: 01 ca, Ngoại chấn thương: 01 ca)

IV.KẾT QUẢ:

4.1 Số ca NKBV theo từng khoa khoa năm 2025

Bảng 1. Số ca NKBV theo từng khoa năm 2025

Khoa	NKVM	NK Catheter	NKH	VPBV	VPTM	NT tiểu	Tổng số
Ngoại TQ	-	-	-	-	-	-	-
Ngoại CT	01	-	-	-	-	-	01
Nội TQ	-	-	-	-	-	-	-
Nội TH	-	-	-	-	-	-	-
Nội nhiễm	-	-	-	-	-	-	-
Nhi	-	-	-	-	-	-	-
Sản	01	-	-	-	-	-	01
Hscc	-	-	-	-	-	-	-
Tổng	02	**0**	0	0	0	0	**02**

Nhận xét: Số ca NKBV xuất hiện trong năm 2025 là nhiễm khuẩn vết mổ, xuất hiện ở khoa sản và Ngoại chấn thương.

4.2 Thống kê số liệu theo từng khoa năm 2025

Bảng 2. Số liệu theo từng khoa năm năm 2025

Khoa	Số BN nhập viện	Số ngày điều trị nội trú	Số BN đặt catheter ngoại biên	Số BN thông tiểu	Số BN đặt TMTT	Số BN thở máy	Số BNPT
Ngoại TQ	804	3593	1402	78			644
Ngoại CT	812	4142	1401	37			365
Nội TQ	3409	14549,47	3979	0			0
Nội TH	2018	5672,75	3318	0			0
Nội nhiễm	1200	6448	1790	0			0
Nhi	2727	11271,25	3615	0			0
Sản	1481	6465	978	284			894
HSCC	819	1531	1621	154		66	0
Tổng số	13270	53672,47	18104	553	0	66	1903

Nhận xét:

- Số bệnh nhân nhập viện và số ngày điều trị nội trú 2025 tăng cao nhất ở khoa Nội tổng quát và khoa Nhi.
- Số BN đặt catheter ngoại biên chiếm số lượng lớn ở Khoa Nội Tổng Quát. Nội Tiêu Hoá và Nhi.
- Số BN thông tiểu tập trung chủ yếu ở khoa Ngoại, Sản, và HSCC.
- Số BN thở máy hầu như chỉ có ở khoa HSCC.
- Khoa có nhiều bệnh nhân làm phẫu thuật bao gồm Ngoại Tổng Quát, Ngoại Chấn Thương, và Sản.

$$\textbf{Tỉ lệ NKBV/ BN nhập viện} = \frac{\text{Số NKBV}}{\text{Số BN nhập viện}} \text{ x } 100$$

$$\textbf{Tỉ lệ NKBV/1000 ngày nằm viện} = \frac{\text{Số NKBV}}{\text{Số nằm viện/ngày}} \text{ x } 1000$$

$$\textbf{Tỉ lệ VPBV/BN nhập viện} = \frac{\text{Số VPBV}}{\text{Số BN nhập viện}} \text{ x}100$$

$$\textbf{Tỉ lệ VPTM/1000 ngày TM} = \frac{\text{Số VPTM}}{\text{Số TM}-\text{ngày}} \text{ x}1000$$

$$\text{Tỉ lệ NKH/1000 đường truyền TM/ngày} = \frac{\text{Số NKH}}{\text{Số đường truyềnTM} - \text{ngày}} \times 1000$$

$$\text{Tỉ lệ NKN/1000 thông tiểu/ngày} = \frac{\text{Số NKN}}{\text{Số thông tiểu} - \text{ngày}} \times 1000$$

$$\text{Tỉ lệ NKVM} = \frac{\text{Số NKVM}}{\text{SỐ BN PT}} \times 100$$

4.3 Phân loại tỉ lệ các loại NKBV năm 2025

Bảng 3. Tỷ lệ các loại NKBV thường gặp năm 2025

Phân loại	Tần số	Tỉ lệ (%)
VP	0/2	0
NKVM	2/2	100
NK Catheter	0/2	0
NKNiệu	0/2	0

Nhận xét: Tỷ lệ NK vết mổ trong năm 2025 chiếm tỷ lệ tối đa

4.4 Tỷ lệ các loại NKBV năm 2025

Bảng 4. Tỷ lệ các loại NKBV năm 2025

Khoa	Tỉ lệ NKBV /BN nhập viện	Tỉ lệ NKBV /1000 ngày nằm viện	Tỉ lệ VPBV /BN nhập viện	Tỉ lệ VPTM /1000 ngày TM	Tỉ lệ NK catheter /1000 đường truyền TM	Tỉ lệ NK Niệu /1000 thông tiểu	Tỉ lệ NKVM
Ngoại TQ	-	-	-	-	-	-	-
Ngoại CT	0,12	0,1	-	-	-	-	0,27
Nội TQ	-	-	-	-	-	-	-
Nội TH	-	-	-	-	-	-	-
Nội nhiễm	-	-	-	-	-	-	-
Nhi	-	-	-	-	-	-	-
Sản	0,07	0,1	-	-	-	-	0,1

HSCC	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số	0,015	0,8	-	-	-	-	0,05

Nhận xét: Tỷ lệ NKBV/BN nhập viện tại BV Nhật Tân cả năm 2025 là 0,015% trong đó tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 0,05%.

V.KẾT LUẬN:

Tỉ lệ NKBV/BN nhập viện tại BV Nhật Tân năm 2025 là 0,015% giảm so với năm 2024 là 0,04%

Các loại NKBV thường gặp so với các loại nhiễm khẩn khác trong bệnh viện năm 2025 là nhiễm khuẩn vết mổ.

VII. KIẾN NGHỊ:

Để hạn chế tình trạng NKBV, chúng tôi đề nghị:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế KSNK trong tất cả các khâu: điều trị, chăm sóc BN, tiệt khuẩn khoa, phòng và y dụng cụ.
2. Tập huấn thường xuyên Quy chế KSNK cho NVYT.
3. Giám sát tình hình NKBV tại các khoa và có phản hồi kịp thời để các khoa có hướng xử lý,khắc phục.
4. Điều dưỡng trưởng tăng cường kiểm tra giám sát NVYT tại khoa về KSNK trong chăm sóc bệnh nhân.
5. Các thành viên trong mạng lưới KSNK tại các khoa theo dõi sát các trường hợp nghi ngờ hay xác định NKBV và báo cáo kịp thời để có biện pháp cách ly,phòng ngừa nhằm hạn chế lan truyền mầm bệnh
6. Có những hình thức khen thưởng những khoa thực hiện tốt công tác KSNK,cũng như nhắc nhở những khoa thực hiện chưa tốt

VIẾT TẮT:

NKBV	nhiễm khuẩn bệnh viện
KSNK	kiểm soát nhiễm khuẩn
CDC	Centers for Disease Control and Prevention Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh
NVYT	nhân viên y tế
BN	bệnh nhân
PT	phẫu thuật

Người báo cáo

Ds. Bùi Thị Minh Thư